

Estado de México, a 19 de Agosto de 2025 fecha automática
Peso:68.200kg Talla:164cm T/A:109/61mmHg peso

A quien corresponda lista de medicos

Paciente:

Maria Fernanda Garcia Chavarria

Estudio Solicitado:

Crecimiento Fetal, Evaluación
placentaria

Fecha de última regla (FUM)

Edad gestacional (FUM):

29.0 semanas

Fecha probable de parto (FUM):

08 de Noviembre de 2025

Fecha probable de parto (USG):

01 de Noviembre de 2025

Se realizó estudio ultrasonografico de alta definición, utilizando un equipo General Electric Volusson Expert con transductor convexo transabdominal, volumétrico de banda ancha, encontrando:

- Feto único vivo / muerto, si sale vivo Frecuencia cardiaca afetal xxx latidos / minuto
- Situación: Longitudinal Transversa
 - Presentación: Cefalico / pélvico si es longitudinal,
 - Posición: Dorso anterior, dorso posterior polo cefálico derecho o polo cefalizo izquierdo.
 - Placenta Corporal anterior, posterior lateralizada a la derecha oo a la izquierda Clasificacion FIGO
 -

Impresión diagnóstica:

Embarazo de **29.3** semanas por fetometría, con peso fetal estimado de **Peso Estimado Fetal: 1335 +- 195 g**

- Percentil ajustado de Crecimiento Fetal: **40** para la edad gestacional y el género fetal
- Doble circular de cordon en cuello.

Comentario:

Crecimiento fetal **es adecuado si está en percentil 11- 89**

Mayor a lo esperado si está en percentil mayor al 90

Menor a lo esperado si está en percentil menor al 10

En tal caso, clasifica como : Aquí van las condicionales

Estadio RCIU (Barcelona)	Criterios ecográficos / Doppler	Fisiopatología	Seguimiento y conducta
Estadio I – Incipiente / leve	PFE < p10 o circunferencia abdominal (CA) < p10, con Doppler normal (AU-PI y ACM-PI dentro de límites).	Disfunción placentaria mínima o constitucional; feto compensado.	Control ecográfico y Doppler cada 3–4 semanas . Evaluar crecimiento, perfil biofisico y bienestar fetal.
Estadio II – Moderado	PFE < p10 con arteria umbilical (AU-PI > p95) o índice cerebroplacentario (ICP) bajo (<p5).	Aumento de resistencia placentaria con redistribución hemodinámica	Ecografía y Doppler cada 2 semanas , control clínico semanal. Iniciar vigilancia materno-fetal mas estrecha .

StarMedica Tlalnepantla
Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601

Hospital San Angel Inn Satélite
Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

Estadio RCIU (Barcelona)	Criterios ecográficos / Doppler	Fisiopatología fetal.	Seguimiento y conducta
Estadio III – Severo	PFE < p3 o alteraciones severas: flujo diastólico ausente o reverso en AU, ICP < p3.	Compromiso hemodinámico fetal avanzado; riesgo de hipoxia y acidosis.	Seguimiento hospitalario; Doppler cada 48–72 h ; maduración pulmonar y planificación de parto entre 32–34 sem según evolución.
Estadio IV – Preterminal / compromiso crítico	Flujo diastólico ausente/reverso en AU + alteración en ductus venoso (onda A reversa) ± reducción del flujo en vena umbilical.	Feto con redistribución fallida, acidosis fetal inminente.	Hospitalización, monitorización continua . Indicación de parto urgente según estabilidad fetal (usualmente <32 sem).

Se observa un crecimiento fetal armónico entre segmentos.

Evaluación Doppler

- La velocimetría Doppler de arteria umbilical y cerebral media es **normal**, con un índice cerebro placentario normal.

Seguimiento y Conducta... de acuerdo a la tabla de arriba

- El líquido amniótico de tantos mm **si está de 8-25 cm en índice de Phelan o por Bolsillo máximo de 5-8 cm Si está menor se escribe oligohidramnios y si está mayor sale**

Evaluación Estructural Completa/incompleta, adecuada / limitada

Dra. Nallely Moreno Uribe

Especialista en Medicina Materno Fetal C.P.8631423

Antecedentes de importancia

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033, Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

Checklist Prenacer - Antecedentes relevantes para evaluación del tercer trimestre

Categoría	Dato clínico / antecedente	Resultado o comentario
Datos generales	Edad materna	_____ años
	Paridad	_____ G / _____ P / _____ C / _____ A
Antecedentes del primer trimestre	Riesgo de preeclampsia (FMF)	Bajo / Intermedio / Alto
	Doppler uterino temprano	Normal / Alterado
	PAPP-A / PLGF (si disponible)	_____
	Tamizaje genético (DNA fetal / Combinado)	Negativo / Positivo / No realizado
	Longitud cervical inicial	_____ mm
Antecedentes del segundo trimestre	Morfología fetal estructural	Normal / Alterada
	Doppler uterino medio	Normal / Elevado PI
	Signos de restricción del crecimiento	No / Sí (detallar)
	Placenta (localización y aspecto)	_____
	Longitud cervical / funneling / sludge	_____
	Índice de consistencia cervical	_____ %
Antecedentes maternos relevantes	Hipertensión previa o inducida	Sí / No
	Diabetes pregestacional	Sí / No
	Enfermedad tiroidea	Sí / No
	Lupus / SAF / Trombofilias	Sí / No
	Cirugías uterinas previas (miomectomía, cesárea)	Sí / No
	Historia de parto pretérmino	Sí / No (EG _____ sem)
	Restricción del crecimiento en gestación previa	Sí / No
	Hemorragias / amenaza de aborto previa	Sí / No
Control metabólico actual	Curva de tolerancia oral a la glucosa (CTOG 75g o 100g)	Normal / Alterada

StarMedica Tlalnepantla



Hospital San Angel Inn Satélite

	Diagnóstico actual de diabetes gestacional	Sí / No
Factores actuales del tercer trimestre	Presión arterial actual	_____ / _____ mmHg
	Ganancia ponderal total	_____ kg
	Movimientos fetales percibidos	Normales / Disminuidos
	Signos clínicos de amenaza de parto pretérmino	No / Sí (especificar)
	Plan de nacimiento definido	Sí / No

Exploración Estructural Fetal

Cráneo: El contorno craneal muestra morfología ovalada con huesos bien osificados y simétricos. Se observa operculización cerebral completa con surcos de Silvio bien definidos, indicativos de maduración cortical adecuada. Los ventrículos laterales son simétricos, con atrios menores de 10 mm y sin signos de dilatación. El cuerpo calloso es continuo, el cavum septi pellucidi visible y la línea media íntegra. En la fosa posterior, los hemisferios cerebelosos son simétricos, el vermis se observa completo y la cisterna magna mide entre 2 y 10 mm. El diámetro transcerebeloso corresponde a la edad gestacional,

Cara: El perfil facial es armónico, con frente, nariz, labios y mentón alineados. Las órbitas son simétricas, la distancia interpupilar es normal y los cristalinos son visibles. El labio superior y el paladar se observan íntegros, con movimientos deglutorios activos. El cuello es simétrico, sin masas ni engrosamiento nuchal. Circular de cordón a cuello (simple, doble negativo)

Tórax: El corazón presenta situs normal y levocardia fisiológica, ocupando un tercio del tórax con un eje cardíaco aproximado de $45^\circ \pm 10^\circ$. Se observan las cuatro cámaras cardíacas con cavidades proporcionales, septos íntegros y válvulas competentes. Los tractos de salida están bien definidos, con cruzamiento normal de aorta y arteria pulmonar. El índice cardiorácico (ICT) es menor de 0.5, sin cardiomegalia. El ritmo es regular y sin arritmias.

El tórax muestra pulmones de ecogenicidad homogénea y simétrica, sin masas, derrames ni desplazamiento mediastínico. El diafragma es continuo y bien diferenciado del abdomen.

Abdomen: En el abdomen, el estómago se localiza en el cuadrante superior izquierdo, el hígado presenta tamaño y ecogenicidad normal, y la vesícula biliar es visible y de morfología fusiforme. El intestino delgado muestra ecogenicidad fisiológica sin asas

dilatadas, y el tubo digestivo bajo evidencia ampolla rectal anecoica, lo que confirma la canalización anal. La pared abdominal está cerrada, sin defectos, con inserción central del cordón umbilical.

Ambos riñones son visibles, con diferenciación cortico-medular conservada. La pelvis renal anteroposterior mide menos de 7 mm. No hay dilatación ureteral. La vejiga es central, distensible y presenta llenado y vaciado normales..

Columna: La columna vertebral se visualiza en toda su extensión, con continuidad ósea y tegumentaria, sin protrusiones ni alteraciones en la piel. La curvatura fisiológica está conservada y el canal medular es visible y simétrico.

Extremidades: Las extremidades muestran longitudes acordes a la edad gestacional, movimientos activos, tono fetal adecuado y morfología normal de manos y pies. No se identifican acortamientos ni dismorfias

Placenta: Checklist Prenacer - Evaluación ecográfica de la placenta (basado en AJOG 2025 y FIGO 2023)

Parámetro	Valor normal / referencia	Hallazgo / resultado
Localización	Anterior / Posterior / Fúndica / Lateral	_____
Relación con OCI	≥20 mm del OCI = normal	_____ mm
Grado de madurez placentaria	Grado 0–1 normal hasta 34 sem	_____
Grosor placentario	25–50 mm (según EG)	_____ mm
Ecogenicidad	Homogénea	Homogénea / Heterogénea
Lagunas vasculares	Ausentes / mínimas (Grado 0–1 FIGO)	Sí / No / Extensas
Interfase miometrio-placentaria	Íntegra	Intacta / Adelgazada / Discontinua
Zona retroplacentaria	Presente, hipoecoica	Presente / Ausente
Vasos puente miometriales	Ausentes	Ausentes / Presentes
Protrusión	No	Sí / No

placentaria		
Vascularización anómala (Color Doppler)	Flujo periférico fino / sin turbulencia	Normal / Turbulento / Extendido a vejiga
Inserción del cordón	Central / Paracentral / Marginal / Velamentosa	_____
Número de vasos umbilicales	3 vasos	3 / 2
Calcificaciones	Leves en 3er trimestre	Ausentes / Moderadas / Extensas
Índice de perfusión placentaria (Doppler 3D)	VI 20–40%, FI 30–50%, VFI 5–15%	_____
Arteria umbilical (PI)	<p95 para EG	_____
Arteria uterina (PI promedio)	<p95 para EG	_____
Vena umbilical	Flujo continuo, monofásico	Normal / Pulsátil
Observaciones		

Clasificación FIGO – Sospecha de acretismo placentario (PAS)

Grado FIGO	Hallazgos ecográficos clave	Interpretación / nivel de riesgo
Grado 0 (Normal)	Interfase intacta, zona retroplacentaria presente, sin lagunas	Placenta normal
Grado 1 (PAS leve / accreta)	Lagunas finas, adelgazamiento miometrial <1 mm, interfase borrosa	Riesgo bajo
Grado 2 (Invasión moderada / increta)	Lagunas extensas, pérdida de zona retroplacentaria, flujo turbulento	Riesgo intermedio
Grado 3 (Invasión profunda / percreta)	Extensión a serosa o vejiga, vasos puente, flujo turbulento de alta energía	Riesgo alto / manejo multidisciplinario

Interpretación global Prenacer

 **Placenta de morfología y perfusión normal**

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
 Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601

Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
 Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

- Cambios leves / disfunción placentaria temprana
- Sospecha moderada de alteración estructural o hemodinámica
- Alta sospecha de PAS o disfunción placentaria severa

Bibliografía

1. Reddy UM, et al. Placental imaging and structure-function assessment in pregnancy. AJOG, 2025.
2. Jauniaux E, et al. FIGO classification for placenta accreta spectrum disorders. Int J Gynaecol Obstet, 2023.
3. ISUOG Practice Guidelines. Ultrasound assessment of the placenta. UOG, 2023.

Clasificación FIGO de los Leiomiomas Uterinos (2021-2023)

Tipo FIGO	Localización anatómica	Descripción
0	Submucoso pediculado	Completamente intracavitario, unido al endometrio por un pedículo fino.
1	Submucoso con componente intramural <50%	Más del 50% del volumen protruye hacia la cavidad endometrial.
2	Submucoso con componente intramural ≥50%	Menos del 50% del volumen se proyecta dentro de la cavidad endometrial.
3	Intramural en contacto con el endometrio, sin distorsionar la cavidad	Lesión completamente intramural, pero adyacente al endometrio.
4	Intramural puro	Lesión completamente dentro del miometrio, sin contacto con endometrio ni serosa.
5	Subseroso con componente intramural ≥50%	Mayor parte del volumen dentro del miometrio, protruyendo hacia la serosa.
6	Subseroso con componente intramural <50%	Predomina el componente subseroso, con mínima extensión intramural.
7	Subseroso pediculado	Completamente

		extracavitario, unido a la serosa uterina mediante un pedículo.
8	Otros (parasitarios, cervicales, retroperitoneales, ligamento ancho)	Sin relación directa con la cavidad endometrial ni la serosa del cuerpo uterino.
Híbrido (2 números)	Miomas que afectan simultáneamente endometrio y serosa	Se describen con dos números que representan la extensión hacia ambas superficies (p. ej., tipo 2–5).

Bibliografía

1. Munro MG, et al. FIGO Classification System (2021 update): Leiomyoma subclassification. Int J Gynaecol Obstet. 2022.
2. ISUOG Practice Guidelines. Ultrasound assessment of uterine leiomyomas. 2023.
3. Dueholm M, et al. UOG. 2021 – Imaging-based classification of fibroids.
4. Donnez J, Dolmans MM. N Engl J Med. 2016 – Uterine fibroids and reproductive outcomes.

Registro ecográfico Prenacer de miomas identificados

# Miom a	Tipo FIGO	Localizació n uterina	Dimensio n (mm)	Relació n con cavidad / serosa	Vascularizació n (Doppler)	Observacione s clínicas
1	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

3. Evaluación Doppler fetal y materno – Ratio 37 (Creswell & Lees, UOG 2023)

Se evaluaron los principales vasos fetales y maternos mediante Doppler pulsado: la arteria umbilical (AU) con IP de _____ (percentil _____), flujo diastólico presente / ausente / reverso; la arteria cerebral media (ACM) con IP de _____ (MoM _____), PSV _____ cm/s; el ductus venoso (DV) con IP de _____ y onda A positiva / ausente / reversa; y las arterias uterinas izquierda y derecha con IP promedio de _____ (percentil _____). El cociente cerebro-placentario (C/U Ratio = ACM/AU) es de _____.

Cuadro de interpretación Doppler – Ratio 37

Índice Doppler	Medición	Morfología	Punto de corte	Interpretación
IP Umbilical		Diástole Presente Diastole Ausente	$\geq p95$	Disfunción placentaria
IP Cerebral media			$< p5$	Redistribución cerebral
Ratio (ACM/AU)			< 1.0	Compromiso hemodinámico
IP Ductus venoso		Onda A Presente Onda A Ausente	$> p95$	Alteración venosa
IP medio Uterinas			$\geq p95$	Alta resistencia placentaria

Este estudio ecográfico se realizó conforme a las guías ISUOG 2025 y los protocolos Prenacer. El ultrasonido obstétrico es un método dinámico y operador-dependiente, limitado por factores como posición fetal, cantidad de líquido amniótico, constitución materna y edad gestacional. El objetivo del examen es evaluar la anatomía, el crecimiento y el bienestar fetal en el momento de la exploración. El estudio no sustituye la vigilancia clínica ni garantiza la ausencia futura de enfermedad o malformaciones estructurales menores, genéticas o metabólicas. Los hallazgos deben interpretarse dentro del contexto clínico global. Cualquier sospecha deberá corroborarse con estudios complementarios según la evolución materno-fetal.

Nota de Responsabilidad Médico-Legal

El estudio del tercer trimestre es útil para evaluar el crecimiento fetal y analizar indirectamente el ecosistema fetal. Este estudio ha demostrado cierta utilidad en diagnosticar alteraciones estructurales sobre todo en el sistema genitourinario, sistema nervioso central y corazón. Si bien la capacidad de detección de esta prueba es especialmente baja para anomalías cromosómicas. Se ha resaltado su utilidad diagnóstica en las alteraciones del crecimiento fetal, además de evidenciar adecuadamente la estructura placentaria y las anomalías en dicha estructura así como vasa previa, por lo que su valor para prevenir hemorragia obstétrica es importante. De este estudio se resalta sobre todo la posibilidad de preparar al equipo de salud que atenderá el nacimiento. Como todos los estudios ultrasonográficos el valor diagnóstico puede verse afectado por diversos factores tales como: características de la transmisión del ultrasonido, características maternas, posición y movimientos fetales. Este estudio se ha realizado siguiendo las normas de la Sociedad

Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia (ISUOG, 2024). No se recomienda tomar decisiones obstétricas basadas únicamente en los resultados de este estudio. Las indicaciones aquí sugeridas no constituyen un actuar médico. Toda decisión médica y tratamiento son responsabilidad de su médico tratante

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630